

Περίπτωση 31η

Άνδρας 68 ετών, με γνωστό ιστορικό ΧΑΠ υπό οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με δύσπνοια προοδευτικά επιδεινούμενη, παραγωγικό βήχα και διάρροιες από διημέρου.

- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 56 mmHg
- PCO₂ = 60 mmHg
- pH = 7.22
- [HCO₃⁻] = 24 mEq/L
- [Na⁺] = 137 mEq/L
- [K⁺] = 4.0 mEq/L
- [Cl⁻] = 101 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 107 mg/dl
- [Ουρίας] = 52 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.1 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση

- pH = 7.22 (< 7.40)
- PCO₂ = 60 mmHg (> 40 mmHg)
- **Αναπνευστική οξέωση (κύρια διαταραχή)**

Η αναπνευστική οξέωση είναι οξεία ή χρόνια; Αμιγής ή συνυπάρχει μεταβολική διαταραχή;

- $[\text{HCO}_3^-] = 24 \text{ mEq/L}$ (φυσιολογική)
- $\text{PCO}_2 = 60 \text{ mmHg}$, $\uparrow$ κατά 20 mmHg
- Οξεία ΑΟ (;) $\Rightarrow \uparrow [\text{HCO}_3^-]$ κατά 1 mEq/L για κάθε $10 \text{ mmHg} \uparrow$ της PCO_2 , δηλαδή $[\text{HCO}_3^-] = 24 + 2 = 26 \text{ mEq/L}$
- $\uparrow [\text{HCO}_3^-] < 1 \text{ mEq/L}$ για κάθε $10 \text{ mmHg} \uparrow$ της PCO_2
- **Αναπνευστική οξέωση + Μεταβολική οξέωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

pH <7,4 και PCO₂ >40 mmHg

Αναπνευστική οξέωση

Πόση είναι η [HCO₃⁻]

↑ [HCO₃⁻] είναι <1 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική οξέωση

↑ [HCO₃⁻] = 1 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Οξεία αναπνευστική
οξέωση

↑ [HCO₃⁻] = 1-3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

- Περίοδος
μετάβασης
- Μικτή διαταραχή

↑ [HCO₃⁻] = 3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Χρόνια
αναπνευστική οξέωση

↑ [HCO₃⁻] είναι >3,5 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↑ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική αλκάλωση

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 137 - (101+24) = 12 \text{ mEq/L}$
- AG φυσιολογικό
- Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό AG που οφείλεται στις διάρροιες (άμεση απώλεια $[HCO_3^-]$ από το ΓΕΣ)

(A-a) DO₂

- (A-a) DO₂ = [150 – 1.25 X (PCO₂)] - PaO₂ = [150 – (1.25 X 60)] – 56 = 150 – 75 – 56 = 19 mmHg
- ↑ (A-a) DO₂ = πνευμονική νόσος (ΧΑΠ)

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει αναπνευστική οξέωση και μεταβολική οξέωση λόγω παρόξυνσης ΧΑΠ και διαρροιών

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση